

Roadmap per il primo MVP

Dallo stato attuale del materiale a una web app mobile utilizzabile da un gruppo pilota di atlete. Cosa esiste, cosa manca, in quanto tempo e a quali condizioni.

DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	ORIZZONTE
Roadmap MVP	1.0	5 agosto 2026	3 settimane

Specifica di prodotto, non consiglio medico. Tutte le soglie cliniche, l'instradamento delle bandiere rosse e i percorsi mestruali/RED-S devono essere rivisti e firmati da un medico dello sport qualificato, e l'affidabilità degli strumenti stabilita per fascia d'età, prima dell'uso con minori.

Cosa costruiamo

Una riga sola, da cui discende ogni decisione presa in questo documento.

Quasi tutta la tecnologia sportiva misura l'atleta **dall'esterno** e le dice cosa fare. BAB fa l'opposto: insegna a una ragazza a **leggere il proprio corpo**.

Il meccanismo è un ciclo di calibrazione ripetuto due volte al giorno di allenamento, con un tetto rigido di **60-90 secondi** per volta.

MOMENTO	PASSI	COSA PRODUCE
Prima	Predict → Tune in → Compare → Adjust	Il tempo di oggi: ⚡ Upbeat, 🌊 Steady o 🌿 Gentle
Dopo	Look back → Sense → Learn → Recover	L'errore di previsione della sessione
Sempre	Segnalazione immediata a un tocco	Instradamento immediato in caso di bandiera rossa

La metrica del prodotto

Non è la forma fisica, il recupero o l'aderenza. È il **prediction error in calo**: quanto bene lei si legge, e se quello scarto si sta accorciando. Funziona con o senza dispositivo indossabile.

Conseguenza pratica: la domanda ricorrente dell'app è «*quanto bene mi sono letta oggi?*» — mai «*quanto sono in forma?*».

I tre output, distinti

OUTPUT	DOVE VIVE
Decode capire cos'è normale per lei	Vista «Me»
Decide la chiamata quotidiana	Check-in
Communicate prove per un adulto	Body-story

Vincoli non negoziabili

- Nessun punteggio, percentuale o numero rosso.
- Nessun confronto con altre atlete: solo lei contro sé stessa nel tempo.
- Nessun riferimento a cibo, fame, sazietà, peso o corpo come forma.
- Dati di proprietà dell'atleta; condivisione opt-in; ciclo mai incluso per default.
- L'app supporta la decisione, non la prescrive.

Dove siamo, oggettivamente

Misurato sull'inventario completo delle 50 schermate previste dall'MVP.

AREA	PRONTE	PARZIALI	DA FARE	TOT.
Onboarding	4	2	0	6
Home «Oggi» e i suoi stati	6	0	0	6
Flusso pre-allenamento	5	1	2	8
Flusso post-allenamento	5	1	3	9
Segnalazione immediata	3	0	0	3
Percorso 16 settimane	1	1	3	5
Vista «Me» e body-story	7	0	1	8
Impostazioni e sistema	0	0	5	5
Totale	31	6	13	50

⚠ Come va letto questo 62%

È **copertura di design, non di prodotto**. Quello che esiste sono sei prototipi HTML separati: funzionano, ma non condividono dati, non salvano nulla, non hanno account né backend, e non si parlano tra loro. Chiusa la pagina, tutto sparisce.

Come **prodotto spedibile** il livello reale è intorno al **20%**. Il salto che questa roadmap descrive è esattamente quello da «disegni delle stanze» a «casa con impianto elettrico e porta d'ingresso».

Cosa è già stato risolto

ELEMENTO	STATO	NOTA
Riorganizzazione completa del materiale	fatto	21 documenti, dalla visione alla mappa schermate
Lessico sensazioni e bandiere rosse	fatto	Mancavano <i>cede/instabile</i> e <i>gonfia/calda</i> ; ora instradano al Care mode da sole
Segnalazione immediata sempre accessibile	fatto	Richiesta esplicita del documento madre
Onboarding con date ciclo e contraccezione	fatto	Non esisteva: senza, il layer ciclo non funziona
Body-story condivisibile	fatto	Non esisteva: è l'output «Communicate»
Scaffold della web app	fatto	PWA, tab, token · React 19 · Vite 8 · Supabase
Persistenza, account, sincronizzazione	da fare	Settimana 1
Firma clinica e testo legale	da fare	Dipendenza esterna, non tecnica

Tre settimane, cinque fasi

Le fasi 1–4 sono in sequenza. La fase 5 corre in parallelo dal primo giorno.

FASE	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3
1 • Fondamenta			
2 • Memoria			
3 • Cuore quotidiano			
4 • Contorno e tuning			
5 • Sicurezza			

01 Fondamenta

Settimana 1

- Progetto React 19 • Vite 8 • Tailwind 4 — stesso stack della landing, nessuna scelta tecnica nuova
- PWA installabile sulla schermata home, a schermo intero, con service worker
- Design system sui token della landing, definiti in un punto solo
- Navigazione a tre tab e segnalazione immediata persistente

Risultato: app vuota ma reale, installabile su telefono. completato

02 Memoria

Settimana 1

- Autenticazione con link via email — nessuna password da gestire per delle minorenni
- Database Supabase, già in uso sulla landing
- Salvataggio e riletture dei check-in
- Funzionamento offline con sincronizzazione differita: in palestra spesso non c'è campo

Risultato: un check-in fatto oggi si ritrova domani. È il punto in cui smette di essere una demo.

03

Cuore quotidiano

Settimana 2

- Onboarding completo: consenso, età, sport, ritmo con date e contraccezione
- Check-in pre e post completi, con salvataggio reale
- Home «Oggi» con i sei stati calcolati sui dati veri
- Care mode e segnalazione immediata collegati al database

Risultato: un'atleta può usare l'app per una giornata intera, dall'inizio alla fine.

04

Contorno e messa a punto

Settimana 3

- Percorso, mesi 1-2, con le missioni che si spuntano dai check-in reali
- Vista «Me», stadi 1 e 2: contatore di raccolta e prima ipotesi
- Body-story settimanale condivisibile
- Impostazioni: privacy con esporta e cancella, ritmo, notifiche, aiuto
- Strumentazione del pilota, verifica di accessibilità, correzione bug

Risultato: app completa per quanto serve al pilota.

05

Sicurezza e conformità

In parallelo

- **Firma del medico dello sport** su Care mode, bandiere rosse, mappatura clinica, percorsi RED-S e ciclo
- **Testo legale** del consenso tutore e atleta, privacy, GDPR, trattamento dei minori
- Verifica di accessibilità: contrasto AA, target ≥ 44 px, movimento ridotto
- Protocollo del pilota: cosa si misura, come, chi è l'adulto responsabile

Nessuna di queste voci è comprimibile per anticipare il pilota.

Cosa entra e cosa esce

Il criterio non è cosa si riesce a costruire, ma cosa serve per rispondere alle domande del pilota.

ESCLUSO DALLA V1	QUANDO	PERCHÉ IL TAGLIO NON HA COSTO
Vista «Me», stadio fingerprint	v1.1	Richiede circa 9 settimane di dati per esistere: in un pilota non sarebbe visibile prima della fine. Si costruisce durante il pilota stesso.
Percorso, mesi 3 e 4	v1.1	Un pilota di 8–12 settimane non arriva a coprirli. Il contenuto è già scritto per intero.
Mappa corporea semplificata 11–13 anni	v1.1	Il pilota è su atlete di 13–14 anni. Serve quando si allarga la fascia.
Tema scuro	v1.1	Non incide su nessuna delle tre domande del pilota.
Integrazione dispositivi indossabili	v2	Il primo principio del prodotto stabilisce che l'app è pienamente utile senza. È la parte meno differenziante.
Dashboard per il coach	v2 o mai	Sapere che il coach legge i dati cambia ciò che l'atleta riporta, e renderebbe non interpretabile la misura di aderenza del pilota.
Multi-lingua	v1.1	Si spedisce una lingua sola; l'architettura resta predisposta.



Non si taglia mai

- Care mode e bandiere rosse
- Segnalazione immediata sempre a un tocco
- Consenso tutore e atleta
- Esporta e cancella i miei dati
- Target touch ≥ 44 px e contrasto AA
- Le tre misure del pilota



Da strumentare prima di partire

- Secondi reali per completare ogni check-in
- Tempo **suggerito** dall'app contro tempo **scelto** dall'atleta
- Quali domande vengono saltate

Costano poche ore e sono irrecuperabili a posteriori. Il secondo è il dato più prezioso: è l'atleta che corregge il modello.

Criteri di successo del pilota

DOMANDA	MISURA	SOGLIA
1. Lo compilano?	Giorni di allenamento con pre-check completato	≥ 60%
	Atlete ancora attive alla settimana 4	≥ 70%
	Tempo mediano di completamento	≤ 90 s
2. Il meccanismo regge?	Check-in con previsione compilata	≥ 85%
3. Il divario si accorcia?	Prediction error, settimane 1-2 contro 7-8	in calo
Sicurezza	Bandiere rosse comunicate a un adulto	100%

Nota metodologica. Con 20 atlete e 8 settimane non si valida la metrica di body literacy: si validano **aderenza e comprensibilità**. La validazione della metrica richiede l'affidabilità test-retest della mappa corporea per fascia d'età e la verifica within-athlete del prediction error contro esiti reali. Va detto a chiunque legga i risultati, per non trasformare un segnale incoraggiante in un'affermazione.

Rischi e decisioni da prendere

Il piano a tre settimane regge solo se queste condizioni sono soddisfatte.

La distinzione che precede tutto il resto

«App pronta» e «pilota partito» sono due date diverse, e solo la prima dipende dal team. Il pilota con minorenni dipende dalla firma clinica e dal testo legale del consenso: dipendenze esterne, che non si comprimono scrivendo codice più in fretta.

Se la firma arriva entro la settimana 3, il pilota parte. Se non arriva, alla settimana 3 esiste comunque un'app completa da mostrare a club, famiglie e investitori — quindi il tempo non è perso in nessuno dei due scenari.

Decisioni richieste, in ordine di urgenza

#	DECISIONE	ENTRO	COSA BLOCCA
1	Individuare l'advisor clinico	oggi	Care mode, bandiere rosse, percorsi RED-S, contenuti sul ciclo, avvio del pilota. È l'unica voce che non si recupera accelerando dopo.
2	Lingua dell'MVP	sett. 1	Ogni riga di copy. Il materiale è in inglese, il pilota è previsto su atlete italiane di 13-14 anni.
3	Visibilità del coach	sett. 1	Struttura del database e dei permessi, e il posizionamento commerciale verso le squadre. Cambiarla dopo ha un costo.
4	Testo legale del consenso	sett. 2	Onboarding. Attualmente è presente un segnaposto dichiarato.
5	Contenuto del percorso sull'alimentazione	sett. 2	Unico contenuto che tocca il tema cibo, in tensione con un principio dichiarato del prodotto.

Registro dei rischi

RISCHIO	IMPATTO	MITIGAZIONE
La firma clinica non arriva entro la settimana 3	alto	Aprire la ricerca oggi. Se slitta, slitta il pilota, non lo sviluppo: si consegna comunque l'app.
La lingua viene decisa tardi	medio	Stringhe esterne al codice fin dall'inizio, così tradurre resta un'operazione meccanica.
Abbandono nelle prime tre settimane d'uso	alto	Il percorso dà una ragione per esserci che non dipende dai dati accumulati; il Compare restituisce valore già dal primo giorno; il contatore trasforma l'attesa in progresso.
Il check-in supera i 90 secondi	medio	Misurare i tempi reali dalla settimana 2. Se si sfora, si rimuovono per primi gli input non strutturali.
Sotto-riporto dei sintomi da parte delle atlete	medio	Rinforzo positivo esplicito nel copy quando segnalano; classificazione clinica spostata dall'atleta al sistema.

Sintesi

Tre settimane sono sufficienti per **l'applicazione**. Per il **pilota** lo sono soltanto se la firma clinica e il testo legale procedono in parallelo a partire da subito. Il percorso critico del progetto, allo stato attuale, non è tecnico.